جوستاف روسي انترناشيونال - مصر (EPE) * **طلب علاج أول مرة / متردد**

إسم المريض رباعياً : بدرالصباح عبدالجليل عبدالعزيز محمد

المحافظة : القليوبيه **الحي / المدينة :** قليوب **العنوان :** زاويه النجار مركز قليوب

رقم البطاقة : 27810011403585 **رقم التليفون :** 01016856405 **تاريخ تسجيل الإستمارة :** 23-10-2026

العمر(تاريخ الميلاد) : 01-10-1978 **المهنة :** ربه منزل

الإقرار

أقر انا الموقع أدناه انني لا اتمتع باي نظام علاج مثل:-التأمين الصحي-القوات المسلحه-الشرطة-الهيئات-المؤسسات او اي نظام يتعارض مع نظام العلاج علي نفقة الدولة- وسوف اتحمل كافة نفقات العلاج في حالة ثبوت غير ذلك

الإخصائي الاجتماعي **المقر بما فيه**

التوقيع:(----------) **التوقيع:**(----------)

التشخيص الإكلينيكي : سرطان بالثدي (مبادرة)

نتائج الأبحاث : (مرفق)

التشخيص النهائي : سرطان بالثدي (مبادرة)

خطة العلاج : أبحاث أورام مزيد من الابحاث و الاشعات [7954] **قسم العلاج :** الاورام

التعليق على التشخيص : ----------

تقرير اللجنة الثلاثية المتخصصة

الاسم: د/محمد كيلاني **الوظيفة:** ---------- **التوقيع:** ----------

الاسم: د/ندى حسن **الوظيفة:** ---------- **التوقيع:** ----------

الاسم: د/نرمين رمضان **الوظيفة:** ---------- **التوقيع:** ----------

أطلعت اللجنة علي لائحة العلاج الخاصة بالمجالس وتلتزم جهة العلاج بلائحة المجالس الطبية.
كما تقر اللجنة بأن البيانات المدونة فى هذا النموذج صحيحة.

تعتمد صحة البيانات المرفقة
رئيس اللجنة و مدير المستشفي.

تتعهد المستشفى أن لا يتم تنفيذ القرار إلا بعد مراجعة الملف الطبي للمريض وإعادة مناظرة المريض بالمستشفي قبل الصرف.

أعضاء اللجنة

ا.د/ ---------- **ا.د/** ---------- **د/** ---------- **د/** ----------

قرار اللجنة

التشخيص النهائي : ----------
خطة العلاج : ----------
المستشفي : ----------**قسم :** ----------
جهة العلاج : ----------**نفقات :** ----------
ملاحظات : ----------

رئيس	مدير عام	ختم
المجلس الطبي المتخصص	مديرية الشئون الصحية	شعار الجمهورية

Name: بدرالصباح عبدالجليل عبدالعزيز محمد
National ID: 27810011403585

تقرير طبي

السيد

تحية طيبة وبعد,,

إيماء للطلب المقدم من	**بشأن تقرير طبي للمريض**
بقسم:	**رقم طبي:**

نتشرف بأن نوضح فيما يلي تقريرا عن حالته

تاريخ وساعة الدخول : -- --:-- yyyy-mm-dd	**تاريخ وساعة الخروج :** PM 01:17 05-07-2026

وبعد الكشف والفحوصات والمتابعة وجد انة

المريضة تعاني من ورم غير حميد بالثدى و تحتاج الي **Further investigations and imaging**

التاريخ : **05-07-2026**	**الوقت :** **-- --:--**
	الطبيب المعالج : د/شيماء لاشين


جمهورية مصر العربية
بطاقة تحقيق الشخصية
بدر الصباح
عبدالجليل عبدالعزيز محمد عمر
زاوية النجار
مركز قليوب - القليوبية
٢٧٨١٠٠١١٤٠٣٥٨٥
JT6280509


٢٧٨١٠٠١١٤٠٣٥٨٥ ٢٠٢٣/٠٧
حاصله على دبلوم زراعه
انثى مسلمة متزوجة
حمدين كامل محمد شهاب الدين
١١
البطاقة سارية حتى ٢٠٣٠/٠٧/١٥

الاسم: بدر الصباح عبد الجليل التاريخ:

الرقم القومي: ٢٥٨٠-١١٤-٢٧٨١

رقم التليفون: ٠١٢٧١٧٠٦٦٢٨

مستهدفة بالتوعية ○

مستهدفة بالتوعية والفحص الإكلينيكي ○

الوزن	الطول	مؤشر كتلة الجسم	قياس السكر العشوائي	قياس ضغط

• فكري نفسك باستمرار بموعد الفحص الذاتي شهريا

يوليو 2019		أغسطس 2019		سبتمبر 2019	
أكتوبر 2019		نوفمبر 2019		ديسمبر 2019	
يناير 2020		فبراير 2020		مارس 2020	
إبريل 2020		مايو 2020		يونيو 2020	
يوليو 2020		أغسطس 2020		سبتمبر 2020	
أكتوبر 2020		نوفمبر 2020		ديسمبر 2020	
يناير 2021		فبراير 2021		مارس 2021	
إبريل 2021		مايو 2021		يونيو 2021	

- حافظي علي قياس السكر والضغط مرة كل ٦ شهور.
- إذا كنتي في سن الزواج أو الإنجاب، إستشيري بالنظام طبيب لتنظيم الأسرة.
- إطمني، الكشف المبكر بيساعد في السيطرة على الأمراض، وزيادة نسب الشفاء.

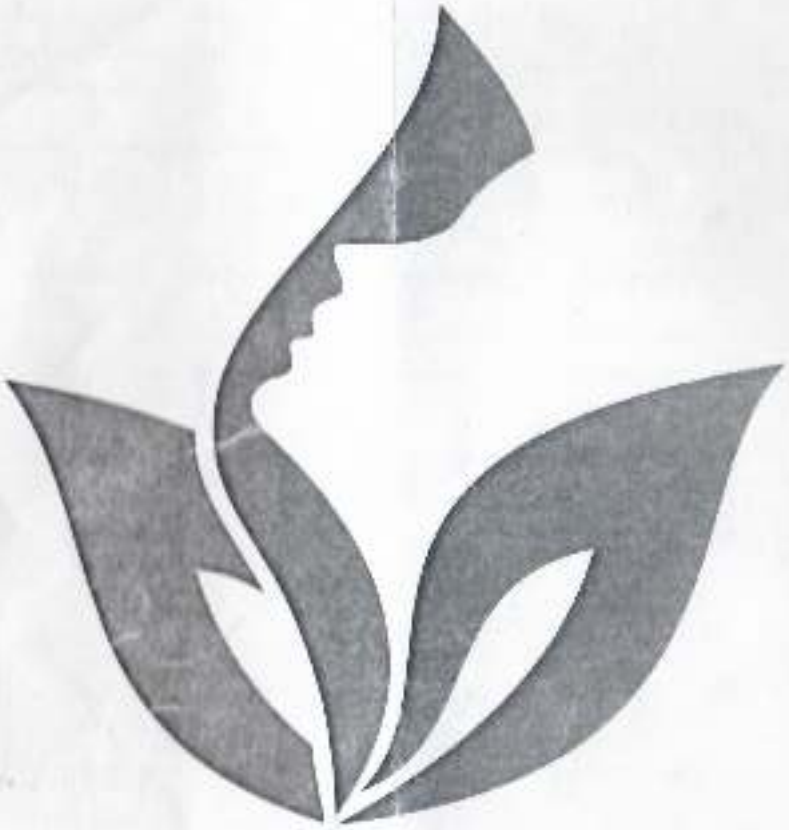
موعد الفحص القادم: توقيع الطبيب:

المكان المحولة له للتقييم: موعد التقييم:

15335 www.100millionseha.eg

مبادرة رئيس الجمهورية
لدعم صحة المرأة المصرية

١٠٠ مليون صحة



الست المصرية هي صحة مصر

منظمة الصحة العالمية
سكرتارية شرق المتوسط

presidential-initiative-card
[[DOCTYPE:OTHER_PRESEDENTIAL_INITIATIVE_CARD]]

مركز النور المحمدي للأشعة
Al-Nour Al-Mohammady Radiological Cente
دوبلر ملون - موجات صوتية - أشعة مقطعية - مفتوح - مغناطيسي
Al-Nour Al-Mohammady Hospital - Abdelhamid Badawi

Dear Prof. Dr : *Date : 29 August 2026*

Patient's name: بدر الصباح

BILATERAL SOFT TISSUE MAMMOGRAPHY AND BREAST U/S

- *ACR b breast parenchymal density of right breast*
- *No gross speculated masses or pathological calcifications on right side*
- *Left breast moderate diffuse oedma with underlying nearly diffuse parenchymal infiltration with associated pathological calcifications and associated large irreguler spiculated high density lesion seen mainly at upper areolar region seen by US as irregular spiculated heterogeneous hypoechoic solid lesion measuring about 4.4x3 cm surrounded with parenchymal oedma and infiltration and nipple retraction*
- *No solid or cystic lesions seen by US on RT side*
- *LT sided pathological level 1 , 11 and 111 axillary LNS largest measures about 3.3x1.8 cm .*
- *RT sided no gross suspicious axillary LNS*

CONCLUSION :-

- ***BIRADS V LT breast picture of lc lly advanced malignant process as described for further management***
- ***RT breast no gross suspicious lesions***

MUCH OBLIGED YOURS.

Dr. OMNIA MOKHTAR M.D

Mammogram
[[DOCTYPE:MAMMOGRAM]]

الهيئة العامة للتامين الصحى
الادارة المركزية لنظم المعلومات و التحول الرقمى

HEALTH INSURANCE ORGANIZATION
CENTER DEPARTMENT OF INFORMATION SYSTEM AND DIGITAL TRANSFORMATION

رسوم الاستعلام 20 جنية

تاريخ الاصدار :2-9-2026 جهه الاصدار :فرع الطويبة

الى من يهمه الامر .....

الهيئه العامة للتامين الصحى تعمل من خلال قوانين منظمة للانتفاع الخاضعين لقانون التامين الاجتماعى رقم 79 لسنه 1975 المعدل بالقانون 25 لسنه 1977 "القوى العامله والمعاشات والارامل " و كذلك قانون 99 لسنه 1992 الخاص بطلاب المدارس و قانون رقم 86 لسنه 2012 " الاطفال دون السن المدرسى" وقانون رقم 23 لسنه 2012 الخاص بالمراة المعيله .

وطبقا لقاعدة البيانات المرسلة من التأمينات الاجتماعيه

وطبقا لقاعدة البيانات المرسلة من الضمان الاجتماعى

والبحث تبين أن

السيد (ة) بدر الصباح عبدالجليل عبدالعزيز بطاقة رقم 27810011403585

تليفون رقم: 01276984268

وطبقا الى خطاب من التأمينات الإجتماعية يفيد عدم الانتفاع
يعتبر من الفئات غير المنتفعه بالتامين الصحى صدر هذا الخطاب دون ادنى مسئولية على الهيئة العامة للتامين الصحى حال خضوع المواطن لقانون التأمين الصحى الشامل
وشكرا

تاريخ الطباعه :2-9-2026

الموظف المختص
سهام عبدالغنى

ادارة مركز نظم المعلومات
يعتمد...

مسلسل 2067728

الخطاب ساري لمدة ثلاثة أشهر من تاريخ الإصدار إلا فى حالة تغيير حالة المواطن من قبل الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية أو وزارة التضامن الاجتماعى أو وزارة التربية و التعليم

الادارة المركزية لنظم المعلومات و التحول الرقمى

رقم الاتصال 0965566

Non-HIO Letter
[[DOCTYPE:NON_HIO_LETTER]]

[[DOCTYPE:ID_FRONT_BACK]]
National ID – Front & Back

جمهورية مصر العربية
بطاقة تحقيق الشخصية



بدر الصباح
عبدالجليل عبدالعزيز محمد عمر
زاوية النجار
مركز قليوب - القليوبية

٢٧٨١٠٠١١٤٠٣٥٨٥

JT6280509

٠١٠١٢٨٥٢٤٠٥

٠١٢٢٢٨٢٠٢٦٤

عينة ٢٠٢٦/٩/٢٤



٢٧٨١٠٠١١٤٠٣٥٨٥ ٢٠٢٣/٠٧
حاصله على دبلوم زراعه

انثى مسلمة متزوجة
حسين كامل محمد شهاب الدين
١١ البطاقة سارية حتى ٢٠٣٠/٠٧/١٠



[[DOCTYPE:PATHOLOGY_REPORT]]
Pathology Report

NHTMRI

الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية
المعهد القومى للكبد والجهاز الهضمي
والأمراض المعدية

قسم الباثولوجى

PATHOLOGY DEPARTMENT
HISTOPATHOLOGICAL REPORT

Patient name: بدر الصباح عبدالجليل عبدالعزيز	**Age:** 48 years	**Sex:** female
Request type: مبادره	**Sub request type:**	
Hospital no:	**Pathology no.:**929-2026	
Department:صحه مرأه	**Date of result:**16/9/2026	
Referred by: د/هبه عزام	**Date of biopsy:**6/9/2026	
Nature of specimen: tru-cut biosy	**I.D. Number:**27810011403585	
Clinical diagnosis: Left breast mass		

Gross pathology :

Multiple fragmented grayish white tissue cores up to 1cm long, totally submitted.

Immunohistochemical Technique:

Sections were prepared from the paraffin block, processed in Benchmark Ultra machine (Ventana) and stained by rabbit monoclonal antibodies using Ultra view HRP DAB as chromogen and hematoxylin as counter-stain. The sections were treated against ER- PR- Her2- KI67

Microscopic picture:

Section examined revealed core of tumor showing invasive duct carcinoma of no special type (NST). The tumor forms nests, tubules and cribriform pattern infiltrating among desmoplastic stroma. Tumor cells showing moderate anaplasia and moderate tendency to from tubules. There is moderate number of mitotic figures.

Immunohistochemical Result

ER: Strong nuclear staining in 90% of tumor cells (Allred Score 8/8).
PR: Weak nuclear staining in 15% of tumor cells (Allred Score 4/8).
Her2: Weak incomplete membranous staining in > 10% of tumor cells (score 1+).
Ki67: Positive nuclear staining of 60% of tumor cells.

Diagnosis: Left breast mass ,Tru-cut biopsy :

Invasive duct carcinoma (NST), Grade II.

Signature:
Dr.Nermine Nabil.M.D

Dr.
24/9/2026

Pathology Lab. Manager

BASMA REFAAT M.D

[[DOCTYPE:MAMMOGRAM]]
Mammogram

مركز النور المحمدي للأشعة
Al-Nour Al-Mohammady Radiological Cente
رنين مغناطيسي مفتوح - أشعة مقطعية - موجات صوتية - دوبلر ملون
Al-Nour Al-Mohammady Mosque - Mesalla Square Tel.: 22517341 - 26509

Dear Prof. Dr : *Date : 29 August 2026*

Patient's name: بدر الصباح

BILATERAL SOFT TISSUE MAMMOGRAPHY AND BREAST U/S

- *ACR b breast parenchymal density of right breast*
- *No gross speculated masses or pathological calcifications on right side*
- *Left breast moderate diffuse oedma with underlying nearly diffuse parenchymal infiltration with associated pathological calcifications and associated large irreguler spiculated high density lesion seen mainly at upper areolar region seen by US as irregular spiculated heterogeneous hypoechoic solid lesion measuring about 4.4x3 cm surrounded with parenchymal oedma and infiltration and nipple retraction*
- *No solid or cystic lesions seen by US on RT side*
- *LT sided pathological level 1 , 11 and 111 axillary LNS largest measures about 3.3x1.8 cm .*
- *RT sided no gross suspicious axillary LNS*

CONCLUSION :-

- ***BIRADS V LT breast picture of locally advanced malignant process as described for further management***
- ***RT breast no gross suspicious lesions .***

MUCH OBLIGED YOURS.

Dr. OMNIA MÓKHTAR M.D

تعرفي على كيفية إجراء الفحص الذاتي للثدي

الخطوة الأولى (أمام المرآة)

- النظري إلى الثديين فى المرآة مع وضع اليدين فى وضع مستقيم على الجانبين ثم وضع اليدين على الوسط.

- تأكدي بالنظر إلى شكل ولون وحجم الثديين، وأنه هو المعتاد بالنسبة لكي دون تغيير أو دون اختلاف بين الثديين.

- لاحظي وجود أي من العلامات التالية بأي من الثديين :

الخطوة الثانية (أمام المرآة)

- إرفعي يديكي إلى أعلى وتأكدي من عدم وجود أي من التغييرات السابقة

الخطوة الثالثة (أمام المرآة)

- أثناء رفع يديكي إلى أعلى، لاحظي خروج أي إفرازات غير طبيعية أو دم من الحلمتين اليمنى أو اليسرى

الخطوة الرابعة (على السرير)

- إستلقي على السرير، إستخدمي اليد اليسرى لفحص الثدي الأيمن واليد اليمنى لفحص الثدي الأيسر.

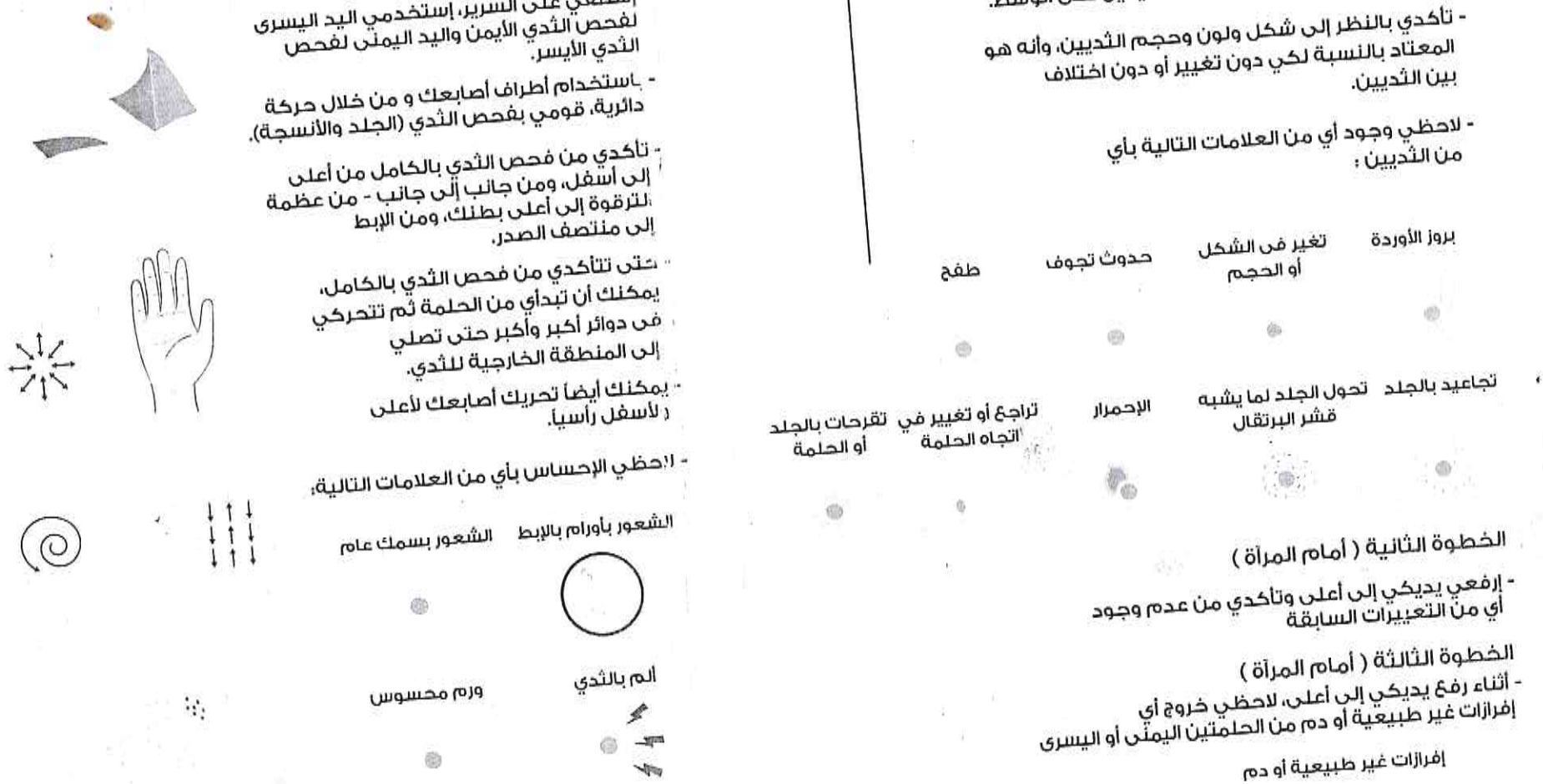
- باستخدام أطراف أصابعك و من خلال حركة دائرية، قومي بفحص الثدي (الجلد والأنسجة).

- تأكدي من فحص الثدي بالكامل من أعلى إلى أسفل، ومن جانب إلى جانب - من عظمة الترقوة إلى أعلى بطنك، ومن الإبط إلى منتصف الصدر.

- حتى تتأكدي من فحص الثدي بالكامل، يمكنك أن تبدأي من الحلمة ثم تتحركي فى دوائر أكبر وأكبر حتى تصلي إلى المنطقة الخارجية للثدي.

- يمكنك أيضاً تحريك أصابعك لأعلى و لأسفل رأسياً.

- لاحظي الإحساس بأي من العلامات التالية:



الخطوة الخامسة (أثناء الإستحمام)

- أعيدي الفحص السابق بنفس الطريقة المذكورة أثناء الإستحمام والجلد مبتل.

- أفضل توقيت لتقومي بالفحص الذاتي للثدي بعد آخر يوم في الدورة الشهرية أو في حالة إنقطاع الدورة الشهرية حددي يوم ثابت شهريا لإجراء الفحص.

- في حال ملاحظة أى من العلامات السابقة توجهي الى عيادة صحة المرأة بالوحدة الصحية

presedential-initiative-card
[[DOCTYPE:OTHER=PRESEDENTIAL_INITIATIVE_CARD]]

جمهورية مصر العربية
بطاقة تحقيق الشخصية



بدر الصباح
عبدالجليل عبدالعزيز محمد عمر
زاوية النجار
مركز قليوب - القليوبية

٢٧٨١٠٠١١٤٠٣٥٨٥

JT6280509

٠١٠١٢٨٥٢٤٠٥

٠١٢٢٢٨٢٠٢٦٤

عينة ٢٠٢٦/٩/٢٤

٢٧٨١٠٠١١٤٠٣٥٨٥ ٢٠٢٣/٠٧
حاصله على دبلوم زراعه

انثى مسلمة متزوجة
حسين كامل محمد شهاب الدين
١١ البطاقة سارية حتى ٢٠٣٠/٠٧/١٠

NHTMRI

الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية
المعهد القومى للكبد والجهاز الهضمي
والأمراض المعدية

قسم الباثولوجى

PATHOLOGY DEPARTMENT
HISTOPATHOLOGICAL REPORT

Patient name: بدر الصباح عبدالجليل عبدالعزيز	**Age:** 48 years	**Sex:** female
Request type: مبادره	**Sub request type:**	
Hospital no:	**Pathology no.:**929-2026	
Department:صحه مرأه	**Date of result:**16/9/2026	
Referred by: د/هبه عزام	**Date of biopsy:**6/9/2026	
Nature of specimen: tru-cut biosy	**I.D. Number:**27810011403585	
Clinical diagnosis: Left breast mass		

Gross pathology :

Multiple fragmented grayish white tissue cores up to 1cm long, totally submitted.

Immunohistochemical Technique:

Sections were prepared from the paraffin block, processed in Benchmark Ultra machine (Ventana) and stained by rabbit monoclonal antibodies using Ultra view HRP DAB as chromogen and hematoxylin as counter-stain. The sections were treated against ER- PR- Her2- KI67

Microscopic picture:

Section examined revealed core of tumor showing invasive duct carcinoma of no special type (NST). The tumor forms nests, tubules and cribriform pattern infiltrating among desmoplastic stroma. Tumor cells showing moderate anaplasia and moderate tendency to from tubules. There is moderate number of mitotic figures.

Immunohistochemical Result

ER: Strong nuclear staining in 90% of tumor cells (Allred Score 8/8).
PR: Weak nuclear staining in 15% of tumor cells (Allred Score 4/8).
Her2: Weak incomplete membranous staining in > 10% of tumor cells (score 1+).
Ki67: Positive nuclear staining of 60% of tumor cells.

Diagnosis: Left breast mass ,Tru-cut biopsy :

Invasive duct carcinoma (NST), Grade II.

Signature:
Dr.Nermine Nabil.M.D

Dr.
24/9/2026

Pathology Lab. Manager

BASMA REFAAT M.D

مركز النور المحمدي للأشعة
Al-Nour Al-Mohammady Radiological Cente
رنين مغناطيسي مفتوح - أشعة مقطعية - موجات صوتية - دوبلر ملون
Al-Nour Al-Mohammady Mosque - Mesalla Square Tel.: 22517341 - 26509

Date : 29 August 2026

Dear Prof. Dr :
Patient's name: بدر الصباح

BILATERAL SOFT TISSUE MAMMOGRAPHY AND BREAST U/S

- ACR b breast parenchymal density of right breast
- No gross speculated masses or pathological calcifications on right side
- Left breast moderate diffuse oedma with underlying nearly diffuse parenchymal infiltration with associated pathological calcifications and associated large irreguler spiculated high density lesion seen mainly at upper areolar region seen by US as irregular spiculated heterogeneous hypoechoic solid lesion measuring about 4.4x3 cm surrounded with parenchymal oedma and infiltration and nipple retraction
- No solid or cystic lesions seen by US on RT side
- LT sided pathological level 1 , 11 and 111 axillary LNS largest measures about 3.3x1.8 cm .
- RT sided no gross suspicious axillary LNS

CONCLUSION :-

- **BIRADS V LT breast picture of locally advanced malignant process as described for further management**
- **RT breast no gross suspicious lesions**

MUCH OBLIGED YOURS.

Dr. OMNIA MÓKHTAR M.D

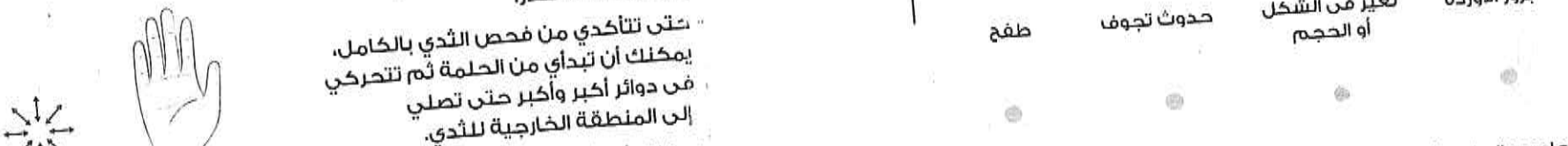
تعرفي على كيفية إجراء الفحص الذاتي للثدي

الخطوة الأولى (أمام المرآة)

- انظري إلى الثديين فى المرآة مع وضع اليدين فى وضع مستقيم على الجانبين ثم وضع اليدين على الوسط.

- تأكدي بالنظر إلى شكل ولون وحجم الثديين، وأنه هو المعتاد بالنسبة لكي دون تغيير أو دون اختلاف بين الثديين.

- لاحظي وجود أي من العلامات التالية بأي من الثديين :



الخطوة الثانية (أمام المرآة)

- إرفعي يديكي إلى أعلى وتأكدي من عدم وجود أي من التغييرات السابقة

الخطوة الثالثة (أمام المرآة)

- أثناء رفع يديكي إلى أعلى، لاحظي خروج أي إفرازات غير طبيعية أو دم من الحلمتين اليمنى أو اليسرى

الخطوة الرابعة (على السرير)

- إستلقي على السرير، إستخدمي اليد اليسرى لفحص الثدي الأيمن واليد اليمنى لفحص الثدي الأيسر.

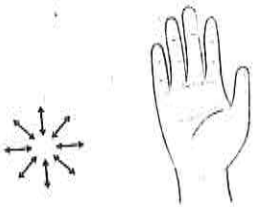
- باستخدام أطراف أصابعك و من خلال حركة دائرية، قومي بفحص الثدي (الجلد والأنسجة).

- تأكدي من فحص الثدي بالكامل من أعلى إلى أسفل، ومن جانب إلى جانب - من عظمة الترقوة إلى أعلى بطنك، ومن الإبط إلى منتصف الصدر.

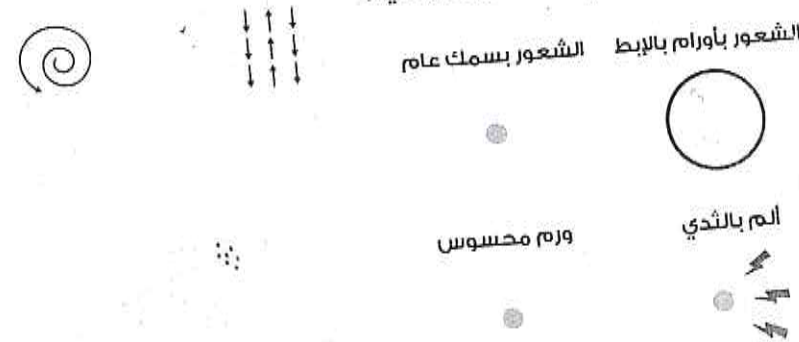
- حتى تتأكدي من فحص الثدي بالكامل، يمكنك أن تبدأي من الحلمة ثم تتحركي فى دوائر أكبر وأكبر حتى تصلي إلى المنطقة الخارجية للثدي.

- يمكنك أيضاً تحريك أصابعك لأعلى و لأسفل رأسياً.





- لاحظي الإحساس بأي من العلامات التالية:



الخطوة الخامسة (أثناء الإستحمام)

- أعيدي الفحص السابق بنفس الطريقة المذكورة أثناء الإستحمام والجلد مبتل.

- في حال ملاحظة أى من العلامات السابقة توجهي إلى عيادة صحة المرأة بالوحدة الصحية

- أفضل توقيت لتقومي بالفحص الذاتي للثدي بعد آخر يوم في الدورة الشهرية أو في حالة إنقطاع الدورة الشهرية حددي يوم ثابت شهريا لإجراء الفحص.